

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SÍNDROMES PRODRÓMICOS (SIPS)

Structured Interview for Prodromal Syndromes (McGlashan, Miller, Woods et al., 2001) · Adaptación española: Bobes, Arango et al.

Paciente / Código:	Edad:	Fecha:
Evaluador / Servicio:	Sexo: ☐ F ☐ M Nº Historia Clínica:	Programa: ☐ Intervención Temprana ☐ CSM

INSTRUCCIONES CLÍNICAS: Entrevista semiestructurada para identificar Estados Mentales de Alto Riesgo (ARMS / UHR) de transición a psicosis. Se evalúan los tres síndromes de riesgo según los criterios SOPS (Escala de Síntomas Prodrómicos: P1 Contenido del pensamiento inusual, P2 Desconfianza/Ideación paranoide, P3 Experiencias perceptivas anormales, P4 Lenguaje desorganizado, P5 Ideas de grandeza).

1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRES SÍNDROMES PRODRÓMICOS (SIPS / SOPS)

Síndrome Prodrómico SIPS	Criterios Operativos de Severidad y Frecuencia (SOPS)	Cumple
A. Síndrome de Síntomas Positivos Atenuados (APPS)	Uno o más síntomas positivos (P1-P5) con gravedad atenuada (puntuación 3 a 5 en la SOPS), con inicio o empeoramiento durante el último año, y presentes al menos 1 vez por semana durante el último mes.	☐ SÍ ☐ NO
B. Síndrome Psicótico Intermitente Breve (BIPS)	Presencia de al menos un síntoma positivo franco (puntuación 6 en SOPS), con duración de minutos a pocos días, resuelto espontáneamente antes de 7 días, presente en los últimos 3 meses.	☐ SÍ ☐ NO
C. Síndrome de Deterioro y Riesgo Genético (GRD)	Familiar de 1.er grado con trastorno psicótico O diagnóstico de Trastorno Esquizotípico de la Personalidad en el sujeto, asociado a una caída $\geq 30\%$ en la escala EEAG/GAF mantenida durante al menos un mes.	☐ SÍ ☐ NO

2. DICTAMEN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO MENTAL DE RIESGO

SIN CRITERIO ARMS ☐ Negativo para psicosis y sin pródromo de alto riesgo.	ESTADO DE ALTO RIESGO ☐ Cumple criterios APPS, BIPS o GRD (Pródromo Confirmado).	PRIMER EPISODIO FRANCO ☐ Síntoma positivo franco (nivel 6) continuo > 7 días (Psicosis).
--	---	---

NORMAS DE CORRECCIÓN, CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y BAREMOS CLÍNICOS (SIPS / SOPS)

Escala de Severidad de Síntomas SOPS (0 a 6):

0 - Ausente	Sin sintomatología observable ni referida.
1 - Dudoso	Ligeramente fuera de lo habitual; no clínico.
2 - Leve	Leve distorsión; insight plenamente preservado.
3 - Moderado	Umbral APPS: Creencias o percepciones atenuadas.
4 - Moder. Severo	Dificultad marcada para dudar de la vivencia.
5 - Severo	Umbral APPS máximo: Insight vacilante e impacto.
6 - Severo / Psicótico	Convicción delirante o alucinación franca (BIPS/PEP).

Criterios de Pronóstico y Actuación Preventiva:

- **Tasa de Transición a Psicosis:** Un 20% a 40% de los pacientes diagnosticados de APPS/ BIPS/GRD mediante SIPS realizan transición a un primer episodio psicótico en un plazo de 12 a 24 meses sin intervención temprana.
- **Intervención Recomendada:** Psicoterapia cognitivo-conductual orientada al pródromo (CBTp), monitorización semanal estrecha, psicoeducación familiar y tratamiento de comorbilidades afectivas (ansiedad, depresión y consumo de cannabis).